

JOAO PAULO DE CAMPOS FONSECA

MEDICAMENTOS:	Prolopa 4bs / Prometaxol / Bulecar / Alonepine
SINTOMAS/QUEIXAS	Sonolência / Perdas parciais (glifage ext) (unho final sen).
BANHEIRO	1 a 2x
HORA QUE ACORDA	6:00
HORA QUE DORME	00:30
Resp.	nasal
PRATICA EXERCICIO	não está fazendo

IAH = 59.1/h
SpO₂ = 72%

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:	Sim	ALMOÇO:	Sim	LANCHE:	Sim	JANTA:	—
-------	-----	---------	-----	---------	-----	--------	---

27/12 P = autom. p1 tubular

22 P = 10.2 cmH₂O

03/01 IAH = 1.5 e/h

23 M. de uso: 5h 5'
Fuga = 20.4 l/min.

fua.

18/01 P = 9.3 cmH₂O

23 IAH = 1.3 e/h

M. de uso: 5h

Fuga = 24 l/min.

fua.

18/02 P = 9.1 cmH₂O - médio 7.1

23 M. de uso: 5h 40'

Fuga = 32 l/min

Relata sonolência após o almoço. fua.

08/03 P = 7.5 cmH₂O

23 IAH = 0.9 e/h

M. de uso: 5h 5'

Fuga = 6.6 l/min.

12/04 P = 7.6 cmH₂O

2023 IAH = 0.8

M. de uso: 4h 30'

Fuga = 7.2

P95% = 34 l/min

Parkinson / fuga - D boca
cintado fono
ajuste conforto
sempre

24/05 P = 7.6 cmH₂O

23 IAH = 3.4 e/h

M. de uso: 3h

Fuga = 0.2

→ relato mais sonolência diurna
→ 46% tempo < 4 horas

28/06/23 P = 7.6 cmH₂O

IAH = 1.3 e/h

M. de uso: 4h 10 min

Fuga = 3.3 l/min

relato mais sonolência diurna
relato mais fono
boca hansenius

26/07/23 P = 7,6 cmH₂O

IAH = 0,3

m. de uso = 3h19'

fixa ↓ P = 7,0 cmH₂O

rampa 5min A P = 5 cmH₂O inicial

(usou 100% dos dias) → relata dificuldade na
mar não consegue ficar ex - sufocamento
surto eleva cabeça

Bem adaptado, si queixas.

fua

15/08
23

P = 7,0 cmH₂O

IAH = 1,0 e/lv

m. de uso: 3h41'

13/09
23

P = 7,0 cmH₂O

IAH = 0,8 e/lv

m. de uso: 3h48.

medida fuga = 9,8

Bem adapt., porém ele tem

obstrução nasal

Oriento uso de SF0,9%

fua

18/10
23

P = 7,0 cmH₂O

m. de uso: 3h52'

Fuga = 12,7 e/lmin

IAH = 1,1 e/lv

26d. - 50% de uso.

Relata melhora da obstr. nasal.

fua

21/02
24

P = 7,0

m. de uso = 4h6'

IAH = 1,3 e/lv

Fuga = 12,9 e/lpmiu

Bem adaptado

30d - 23d de uso.

77% - 43% ↑ 4 hrs.

fua

24/04
24

P = 7 cmH₂O

IAH = 0,7 e/lh

m. de uso: 4h37m

fuga: 13,2° (945°)

Bem adaptado

Troca de mang. nasal

Troca de filtro

Oriento higienização

Natacha

03/07
24

P = 7 cmH₂O / 7d 14L

IAH = 1,3 e/lh

m. de uso: 3h10'

fuga: 7,0 e/lmin

30d - 26 dias de uso

Relata sentir nariz

~~Bem~~ congestionado

↓ Umidificação 50%

Oriento lavagem d

como fisiológico.

16/09
24

P = 7,0

IAH = 1,4 e/lv

m. de uso: 4hrs

fuga = 5 e/lpm

Bem adapt.

fua

13/11/24

P = 7,0 cmH₂O

IAH = 1,9 e/lh

m. de uso = 4h31min

fuga = 22 e/lmin.

Bem adaptado

refere nariz entupido; tem MMII edemacia
dos

22/01

P = 7,0

m. de uso: 3h30'

→ surto eleva cabeça

relata que a cara, não dor

15/05 P = 7 cmH₂O
m. de uso: 3h50'
IAH = 2,1 e/lv

15/06 P = 7 cmH₂O
IAH = 1,8 e/lv

m. de uso: 4h20'
fuga: 3,8 e/lmin

57/10/01

inicial
= no
no

08/05 P= 7cmH2O
25 M. de uso = 3h50'
IAH = 2.1 e/ev

Traco o bojo.

Sua cláudia

05/06 P= 7cmH2O
25 IAH = 1.8 e/ev
M. de uso: 4h20'
fuga = 3.8 lpu

Relata que tem dificuldade
iniciar o sono, oiente higiene
sono.

Sua cláudia

10/07/25 P= 7cmH2O
IAH = 2.0 e/ev
M. de uso = 5h44 min
fuga = 8.1/min

sonando melhor; mas dorme tarde

Sua

clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Cirurgião de Sono
Especialista em Distúrbios do Sono
Médico em Clínica de Sono
CRM-SP: 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Médica de Sono
Especialista em Distúrbios do Sono
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: João Paulo de Campos Fonseca

EXAME nº: 4832

SOLICITADO POR: Dr. Lauro Celso Sideratos Gonçalves

DATA: 17/02/2021

IDADE: 60 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h30min e concluído às 06h01min. A latência para o sono foi de 3 minutos e a latência para o estágio REM, de 127 minutos. O tempo total de sono foi de 320 minutos (05h20min), com eficiência de sono (TTS / TTR)* de 72,4%. A distribuição do sono mostrou 23,3% de estágio 1, 49,4% de estágio 2, 10% de estágio 3 e 17,3% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 119 minutos em vigília, ocorreram 224 microdespertares (índice: 42/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 59,1/hora, sendo 21,6 apneia/hora e 37,5 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 59,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a saturação média de 87% e a mínima de 72%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono TTR ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (59,1/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (59,1/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente no decúbito dorsal e durante o estágio REM, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 53; máxima: 74 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 3 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (127 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 72,4%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 42/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (23,3%; normal: 8-10%) e a redução do estágio REM (17,3%; normal: 20%). As porcentagens dos estágios 2 (49,4%; normal: 45-55%) e 3 (10%; normal: 10-12%) permaneceram nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 20 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM-SP: 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Paulo Roberto Figueiredo
CRM - 83257

Dr. Enio Naruhiro Kokubu
CRM - 87265

João Paulo de Campos
Fonseca

Solicito avaliação

para a fase de
Graf.

Atentamente

CONCLUSÃO:

Registram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (50,11%)
índice acentuado acima de 30 (horas) e de distúrbio respiratório (apneia/hipopneia) (50,11%)
da oxihemoglobina, principalmente no decúbito dorsal e durante o estágio REM, além
cardíaco sinusal e despretens. As frequências cardíacas tornam: mínima: 53; máxima: 74
bpm.

O exame continuou e valor de índice a 30.
Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente apresentou rapidamente (latência para o sono: 3 min; normal até 30
min). A latência para o estágio REM esteve alongada (127 min; normal: 70 a 120 min).
O tempo total de sono foi de 320 minutos (40,00%). A eficiência do sono (T 3 + T 4 + T 5 + T 6 + T 7 + T 8 + T 9 + T 10 + T 11 + T 12 + T 13 + T 14 + T 15 + T 16 + T 17 + T 18 + T 19 + T 20 + T 21 + T 22 + T 23 + T 24) foi de 72,44% (normal: 85%).
A distribuição do sono mostrou 28,8% de estágio 1, 49,4% de estágio 2, 17,3% de estágio 3
e 4,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceram 118 minutos em vigília
e 224 minutos de sono (68,8%).
O índice de movimentos verticais de membros foi de 0,00.
O índice de apneia/hipopneia foi de 50,11%, sendo 21,8 apneia e 28,3 hipopneia.
O índice de distúrbio respiratório (apneia/hipopneia) (50,11%) foi de
50,11%. A saturação de oxigênio (SpO2) foi de 95,1% (normal: 95-98%).
O TTR - Tempo Total de Registro foi de 127 minutos (105,00%).
O TTR - Tempo Total de Sono foi de 320 minutos (264,00%).
O TTR - Tempo Total de Vigília foi de 118 minutos (98,33%).
O TTR - Tempo Total de Sono e Vigília foi de 438 minutos (362,33%).

Enio Naruhiro Kokubu
Otorrinolaringologista
CRM-87265